

Cơ chế trụ Ăn uống

Bản nháp v0.1, ngày 04/10/2026. Tài liệu triển khai trụ thứ nhất trong *Lý luận Lục Dưỡng v0.3*.
Dùng chung ký hiệu: ☯ = Lục Dưỡng vận dụng; **[C1]** **[C2]** **[C3]** = cấp bằng chứng (mục IX của lý luận).

Cần thẩm định: mọi trích dẫn kinh điển phải được lương y đối chiếu nguyên văn. Mọi con số dinh dưỡng phải được bác sĩ dinh dưỡng xác nhận theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế và Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Các nghiên cứu nêu tên ở đây chỉ để định hướng, cần kiểm tra lại trước khi trích dẫn công khai.

Cách đọc tài liệu

"Cơ chế" ở đây là **chuỗi nhân quả từ một việc làm đến một trạng thái**. Mỗi cơ chế có bốn phần:

- Đông lý:** người xưa giải thích thế nào.
- Tây chứng:** y học hiện đại thấy gì, ở cấp bằng chứng nào.
- Tăng được nuôi:** Thân, Khí, Tâm hay Thần.
- Trong app:** hành vi đo được, lời khuyên, nhắc nhở.

Trụ Ăn uống có **bảy cơ chế**, chia ba nhóm:

Nhóm	Câu hỏi	Cơ chế
A. Ăn gì	Chất liệu đưa vào	1. Ngũ cốc vi dưỡng (cấu trúc bữa ăn) · 2. Ngũ vị điều hoà (mặn, ngọt, béo) · 3. Tứ khí và thể chất (hàn nhiệt)
B. Ăn thế nào	Cách ăn	4. Ấm thực hữu tiết (lượng, tốc độ, chú tâm) · 5. Thuận thời (giờ ăn, bữa tối)
C. Đưa gì khác vào	Chất ngoài thức ăn	6. Uống: nước, trà, cà phê · 7. Tỉu và yên: rượu, thuốc lá

Nền chung cho cả bảy là **cơ chế gốc: Tỳ Vị vận hoá**.

Cơ chế gốc: Tỳ Vị vận hoá

Đông lý

- Tổ Vấn, "Linh lan bí điển luận":* "**Tỳ Vị giả, thương lưỡng chi quan, ngũ vị xuất yên**": Tỳ Vị là quan coi kho lương, ngũ vị từ đó mà ra.
- Tổ Vấn, "Kinh mạch biệt luận"* mô tả đường đi của thức ăn uống: vào Vị, tinh khí được đưa lên Tỳ, Tỳ tán tinh lên Phế, rồi phân bố khắp thân. (*Cần đối chiếu nguyên văn.*)

- Lý Đông Viên (*Tỳ Vị luận*, đời Kim Nguyên): "**Nội thương Tỳ Vị, bách bệnh do sinh**": Tỳ Vị tổn thương bên trong thì trăm bệnh sinh ra.
- Quan niệm "**hữu Vị khí tắc sinh, vô Vị khí tắc tử**": còn Vị khí thì còn sống. (*Cần lương y xác định xuất xứ.*)

Chuỗi Đông lý: thức ăn → Tỳ Vị vận hoá → **thủy cốc tinh vi** → sinh **khí, huyết**, bổ sung **tinh hậu thiên** → nuôi Thân, Khí → (qua tạng Tâm) nuôi Thần. Tỳ chủ **thăng thanh**, Vị chủ **giáng trọc**: thăng giáng thuận thì tiêu hoá tốt, đầu óc nhẹ.

Tỳ **ưa táo, ghét thấp**. Ăn nhiều đồ sống lạnh, ngọt béo, ăn quá no làm Tỳ bị **thấp khốn**: nặng nề, đầy bụng, mệt mỏi, đầu nặng.

Tây chứng

Hiện tượng hiện đại	Tương ứng cổ truyền	Cấp
Tiêu hoá, hấp thu cung cấp năng lượng và nguyên liệu cho mọi mô	Tỳ Vị là nguồn sinh hoá khí huyết	C1
Thiếu sắt, B12, folate gây thiếu máu, mệt mỏi	Huyết hư do Tỳ Vị kém sinh hoá	C1 (về hiện tượng)
Vị sinh vật đường ruột tác động miễn dịch, chuyển hoá; ruột và não liên lạc hai chiều (trục ruột - não)	Tỳ Vị liên quan khí, thần	C2
Bữa ăn nhiều đường, tinh bột tinh chế gây dao động đường huyết, có thể kèm uế oải sau ăn	"Thấp khốn Tỳ": nặng nề sau ăn	C2

Hệ quả cho app 🍴

Mọi lời khuyên của trụ Ăn uống đều trả lời một câu: **việc này giúp hay làm khó Tỳ Vị?** Tín hiệu Tỳ Vị mà người dùng tự cảm nhận được: **ăn ngon miệng, tiêu hoá nhẹ, đại tiện đều, không đầy bụng, không buồn ngủ rũ sau ăn**. Đây là nền của check-in Ăn uống (phần "Đo lường" bên dưới).

A. Ăn gì

Cơ chế 1. Ngũ cốc vi dưỡng: cấu trúc bữa ăn

Đông lý. *Tổ Vấn, "Tạng khí pháp thời luận":* "**Ngũ cốc vi dưỡng, ngũ quả vi trợ, ngũ súc vi ích, ngũ thái vi sung. Khí vị hợp nhi phục chi, dĩ bổ tinh ích khí.**": ngũ cốc để nuôi, quả để giúp, thịt để thêm, rau để đủ. Khí vị hoà hợp mà dùng thì bổ tinh ích khí.

Câu này cho một **thứ bậc**: hạt là gốc, rau quả bổ sung, thịt chỉ "ích" chứ không phải chính. Đây là khung rất gần với bữa cơm Việt truyền thống: cơm, canh rau, một món mặn vừa phải.

Tây chứng.

Khuyến nghị hiện đại	Khớp với kinh điển	Cấp
Rau và quả ít nhất 400 g/ngày (WHO)	Ngũ quả vi trợ, ngũ thái vi sung	C1
Chất xơ ít nhất 25 g/ngày ở người lớn (WHO 2023); ngũ cốc nguyên hạt giảm nguy cơ tim mạch, đái tháo đường type 2, ung thư đại trực tràng	Ngũ cốc vi dưỡng	C1
Chất xơ nuôi vi khuẩn ruột, tạo axit béo chuỗi ngắn có lợi cho niêm mạc ruột và chuyển hoá	Tỳ Vị vận hoá tốt	C2
Thịt đỏ nhiều và thịt chế biến sẵn tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng (IARC xếp thịt chế biến nhóm 1)	Ngũ súc chỉ "vi ích", không làm gốc	C1
Đạm đủ cần cho cơ; người lớn khoảng 0,8 g/kg/ngày, người cao tuổi cần nhiều hơn (khoảng 1,0-1,2 g/kg, theo khuyến nghị PROT-AGE)	Dưỡng hình, chống suy Thân ở tuổi già	C1
Thực phẩm siêu chế biến làm ăn vượt nhu cầu: thử nghiệm của Hall và cộng sự (2019) cho thấy người ăn thêm khoảng 500 kcal/ngày khi ăn tự do	Trái "khí vị hợp nhi phục chi"	C1 (thử nghiệm nhỏ, cần bổ sung)

Chỗ cần cẩn thận: "ngũ cốc vi dưỡng" không có nghĩa là ăn nhiều cơm trắng. Người Việt ăn nhiều gạo trắng; tinh bột tinh chế nhiều liên quan nguy cơ đái tháo đường type 2 [C2]. Lục Dưỡng hiểu "ngũ cốc" là **đa dạng hạt, ưu tiên nguyên hạt hoặc ít xay xát** (gạo lứt một phần, khoai, ngô, đậu) ☞. Không biến thành chế độ "chỉ gạo lứt" (xem cờ đỏ).

Tăng được nuôi: Thân ●●●, Khí ●.

Trong app: - Mô hình **"đĩa cơm Việt"** ☞: nửa đĩa rau, một phần tư cơm hoặc tinh bột (ưu tiên ít xay xát), một phần tư đạm (cá, đậu, trứng, thịt), kèm canh. Cần bác sĩ dinh dưỡng chốt tỷ lệ, có thể tham khảo Tháp dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng. - Check-in nhanh: **"Hôm nay bạn ăn rau mấy bữa?"** (0, 1, 2, 3+). Để trả lời hơn đếm gam. - Lời khuyên tiệm tiến: thêm một nắm rau vào bữa trưa; đổi một phần cơm trắng thành gạo lứt hoặc khoai.

Cơ chế 2. Ngũ vị điều hoà: mặn, ngọt, béo

Đông lý. - *Tố Vấn, "Tuyên minh ngũ khí":* **"Toan nhập Can, khổ nhập Tâm, cam nhập Tỳ, tân nhập Phế, hàn nhập Thận"**: chua vào Can, đắng vào Tâm, ngọt vào Tỳ, cay vào Phế, mặn vào Thận. - *Tố Vấn, "Sinh khí thông thiên luận":* **"Âm chi sở sinh, bản tại ngũ vị; âm chi ngũ cung, thương tại ngũ vị"**: âm sinh ra từ ngũ vị, mà năm tạng cũng bị hại bởi ngũ vị. Đủ vị thì nuôi, lệch vị thì hại. - *Tố Vấn, "Ngũ tạng sinh thành"* mô tả hậu quả ăn thiên một vị, ví dụ **ăn mặn nhiều thì "mạch ngưng sáp"** (mạch đi rít, ú). (*Cần đối chiếu nguyên văn.*) - *Tố Vấn, "Kỳ bệnh luận"*: ăn nhiều đồ ngọt béo sinh chứng **"tiêu khát"** (gần với đái tháo đường). (*Cần đối chiếu.*)

Chuối Đông lý: mỗi vị vào một tạng → vừa đủ thì bổ tạng ấy → thiên một vị thì tạng ấy quá vượng, khắc sang tạng khác → mất quân bình.

Tây chứng. Phần đáng chú ý nhất là hai câu kinh điển trên **khớp với hai nguy cơ dinh dưỡng lớn nhất của người Việt hiện nay:**

Kinh điển	Hiện đại	Cấp
Ăn mặn → mạch ngưng sấp	Muối nhiều làm tăng huyết áp, tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch. WHO khuyên dưới 5 g muối/ngày ; người Việt ăn khoảng gần gấp đôi (điều tra STEPS của Bộ Y tế, cần lấy số mới nhất). Nước mắm, bột canh, mì gói là nguồn muối chính	C1
Ngọt béo → tiêu khát	Đường tự do nhiều, nước ngọt có đường làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường type 2, sâu răng. WHO khuyên đường tự do dưới 10% năng lượng , tốt hơn dưới 5%	C1
Ngũ vị quy kinh từng tạng	Chưa có tương ứng sinh học trực tiếp	C3
Đủ vị, đa dạng	Chế độ ăn đa dạng liên quan đủ vi chất và hệ vi sinh đa dạng	C2

Tăng được nuôi: Thân ●●● (huyết áp, chuyển hoá), Khí ● (tránh dao động đường huyết).

Trong app: - Hai lời khuyên ưu tiên cho người Việt: **giảm mặn** và **giảm nước ngọt**. Đây là hai lời khuyên C1 có tác động lớn nhất. - Mẹo cụ thể theo văn hoá Việt 🇻🇳: chấm nước mắm pha loãng thay vì rót thẳng; không chan nước mắm vào cơm; ăn ít nước dùng mì, phở; giảm bột canh, hạt nêm; thay nước ngọt bằng trà, nước lọc. - Giải thích Ngũ vị như **hình ảnh văn hoá** [C3]: "người xưa nói vị mặn vào Thận, ăn mặn quá thì mạch rít; ngày nay khoa học xác nhận ăn mặn làm tăng huyết áp [C1]". Khuôn mẫu "người xưa dạy... khoa học cũng thấy..." chỉ dùng khi phía Tây chứng thật sự có bằng chứng.

Cơ chế 3. Tứ khí và thể chất: hàn nhiệt

Đông lý. Mỗi thực phẩm có **tính** (hàn, lương, bình, ôn, nhiệt) và **vị**. Nguyên tắc trị pháp: **"hàn giả nhiệt chi, nhiệt giả hàn chi"** (*Tổ Vĩn, "Chí chân yếu đại luận"*): lạnh thì dùng nóng, nóng thì dùng lạnh. Áp dụng cho dưỡng sinh: người thiên hàn ăn đồ ấm, người thiên nhiệt ăn đồ mát; mùa hè thêm đồ mát, mùa đông thêm đồ ấm.

Ví dụ thường dùng ở Việt Nam [C3]:

Tính	Ví dụ
Hàn, lương	Rau má, mướp đắng, bí đao, đậu xanh, cua, ốc, dưa hấu
Bình	Gạo, khoai lang, đậu đen, cá chép
Ôn, nhiệt	Gừng, sả, hành, tiêu, quế, thịt dê, nhãn, vải

Bữa cơm Việt đã có sẵn **phép phối hàn nhiệt**: ăn ốc, cua có gừng, tía tô; ăn cá có gừng, thì là; ăn trứng vịt lộn có rau răm, gừng. Đây là di sản "Nam dược trị Nam nhân" nên đưa vào app 🇻🇳.

Tây chứng. Hệ hàn nhiệt **chưa có tương ứng sinh học được kiểm chứng** [C3]. Một số thành phần có tác dụng sinh học riêng (ví dụ gừng giảm buồn nôn [C1-C2]), nhưng điều này không chứng minh hệ hàn nhiệt.

Vì sao vẫn giữ: đây là ngôn ngữ người Việt dùng hàng ngày ("ăn nhiều nhãn nóng người"). Bỏ đi thì mất gần gũi. Giữ lại thì **luôn gắn nhãn C3** và **không bao giờ dùng để thay lời khuyên C1**.

Trong app: - **Bước lọc thể chất bắt buộc** (lý luận mục V): món ôn nhiệt không gợi ý mạnh cho xu hướng Âm hư, Thấp nhiệt; món hàn lương không gợi ý mạnh cho xu hướng Dương hư, Khí hư. - Gợi ý **theo mùa và miền** 🌐: hè miền Bắc và mùa khô miền Nam thêm canh bí, canh rau má; đông miền Bắc, vùng cao thêm gừng, sả. - **Không bán, không gợi ý được liệu** trong phiên bản đầu. Chỉ dùng ở thực phẩm thông thường.

B. Ăn thế nào

Cơ chế 4. Ăn thực hữu tiết: lượng, tốc độ, chú tâm

Đông lý. - *Thượng cổ thiên chân luận*: "**Ăn thực hữu tiết**": ăn uống có chừng mực. - *Tổ Vãn*, "*Tý luận*": "**Ăn thực tự bội, trường vị nãi thương**": ăn gấp bội thì tràng vị tổn thương. - Kinh nghiệm dân gian và sách dưỡng sinh: **ăn bỷ, tám phần no**; ăn chậm nhai kỹ. - *Luận Ngữ*: "**Thực bất ngữ**": khi ăn không nói nhiều. Lục Dưỡng hiểu là **ăn có chú tâm** 🌐, không phải cấm trò chuyện trong bữa cơm gia đình.

Chuỗi Đông lý: ăn vừa đủ, ăn chậm → Tỳ Vị không bị quá tải → vận hoá trọn vẹn → không sinh thấp, đàm → thân nhẹ, khí thông.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Ăn quá nhu cầu năng lượng kéo dài dẫn đến tăng cân, béo phì, rối loạn chuyển hoá	C1
Tín hiệu no (hormone ruột như GLP-1, PYY) cần thời gian; ăn nhanh liên quan ăn nhiều hơn và nguy cơ béo phì	C2
Ăn trong lúc xem màn hình, mất chú ý làm ăn nhiều hơn ở bữa đó và bữa sau	C2
Can thiệp ăn chánh niệm giảm ăn theo cảm xúc và ăn vô độ	C2
Hạn chế năng lượng vừa phải (thử nghiệm CALERIE) cải thiện một số chỉ dấu chuyển hoá ở người khoẻ	C2

Nói với trụ khác: - **Thiền:** ăn chánh niệm là thiền trong bữa ăn. - **Cảm xúc:** ăn để xoa dịu cảm xúc (ăn theo cảm xúc) là đường nối giữa Hỏa và Thổ. Khi người dùng nhiều lần ghi "ăn vì buồn, căng thẳng", app gợi ý sang trụ Cảm xúc thay vì chỉ khuyên ăn ít lại.

Tăng được nuôi: Thân ●●, Khí ●●, Tâm ● (qua ăn chú tâm).

Trong app: - Check-in: **"Sau bữa chính hôm nay, bạn thấy: nhẹ, vừa, hơi no căng, rất no?"** - Thực hành ngắn 📌: **"Ba miếng đầu chánh niệm"**: ba miếng đầu tiên nhai chậm, cảm nhận vị, không xem điện thoại. - **Tuyệt đối không đếm calo** ở phiên bản đầu và không đặt mục tiêu cân nặng. Cách này giảm rủi ro rối loạn ăn uống và hợp tinh thần "trung độ" (xem cờ đỏ).

Cơ chế 5. Thuận thời: giờ ăn và bữa tối

Đông lý. - Thiên nhân hợp nhất: ban ngày dương khí vượng thì vận hoá mạnh; ban đêm dương khí thu tàng thì vận hoá chậm. - Giờ Thìn (7-9h) là giờ kinh Vị vượng, giờ Tỵ (9-11h) là giờ kinh Tỳ vượng theo *Tý Ngọ lưu chú* [C3]. Vì vậy dân gian coi trọng bữa sáng. - *Tổ Vấn, "Nghịch điều luận": "Vị bất hoà tắc ngọa bất an"*: dạ dày không yên thì ngủ không yên. Ăn khuya, ăn no sát giờ ngủ là trái thời. - Dân gian: **"Sáng ăn như vua, trưa ăn như quan, tối ăn như dân"** (có nhiều dị bản).

Tây chứng (dinh dưỡng theo thời gian, chrononutrition).

Hiện tượng	Cấp
Cơ thể có đồng hồ sinh học ở cả gan, ruột, tụy; dung nạp glucose kém hơn vào buổi tối so với buổi sáng	C1 (về sinh lý)
Ăn no sát giờ ngủ tăng trào ngược dạ dày – thực quản; khuyến nghị lâm sàng là ăn xong trước giờ nằm khoảng 2-3 giờ	C1
Dồn năng lượng vào buổi sáng, ăn tối sớm cải thiện một số chỉ số chuyển hoá trong thử nghiệm nhỏ	C2
Ăn trong khung giờ giới hạn (ví dụ 8-10 tiếng/ngày): giảm cân chủ yếu do ăn ít đi ; thử nghiệm có đối chứng (Liu và cộng sự, NEJM 2022) không thấy hơn hạn chế calo đơn thuần	C2
Ăn uống giờ giấc đều đặn liên quan chuyển hoá tốt hơn; làm ca đêm và ăn đêm liên quan rối loạn chuyển hoá	C2

Tăng được nuôi: Thân ●●, Thần ● (qua giấc ngủ).

Trong app: - Chỉ báo dễ đo: **giờ ăn xong bữa cuối** so với giờ đi ngủ (lấy từ trụ Ngủ nghỉ). - Lời khuyên C1: ăn xong bữa tối trước giờ ngủ ít nhất 2-3 tiếng; bữa tối nhẹ hơn bữa trưa. - **Không quảng bá nhịn ăn gián đoạn** như phương pháp dưỡng sinh. Nếu người dùng tự chọn, phải qua khoá an toàn (thai kỳ, đái tháo đường dùng thuốc, tiền sử rối loạn ăn uống, dưới 18 tuổi). - Người làm ca đêm: cần **lộ trình riêng** 📌 (thuộc tam nhân chế nghị, theo đất – hoàn cảnh sống), không áp giờ ăn chuẩn.

C. Đưa gì khác vào

Cơ chế 6. Uống: nước, trà, cà phê

Đông lý. Tân dịch do Tỳ Vị sinh ra từ thủy cốc. Uống vừa đủ, uống ấm thì Tỳ dễ vận hoá; **uống nhiều đồ lạnh, đá** thì tổn Tỳ dương, sinh thấp [C3]. Trà là thức uống truyền thống

của người Việt, tính lương, thanh nhiệt [C3].

Tây chứng.

Chất	Hiện đại	Cấp
Nước	Nhu cầu thay đổi theo khí hậu, vận động; ở xứ nóng ẩm cần chú ý hơn. Mất nước nhẹ giảm tập trung, tăng mệt	C1 (mất nước) / C2 (tác động nhẹ lên nhận thức)
Nước ngọt có đường, trà sữa	Nguồn đường tự do lớn; liên quan béo phì, đái tháo đường	C1
Cà phê	Ở người lớn khỏe, khoảng tối đa 400 mg caffeine/ngày được coi là an toàn (EFSA); thai kỳ tối đa khoảng 200 mg. Caffeine có thời gian bán thải trung bình khoảng 5 giờ (dao động lớn giữa các người). Uống caffeine 6 giờ trước khi ngủ vẫn làm giảm giấc ngủ (Drake và cộng sự, 2013)	C1
Trà	Uống trà liên quan một số lợi ích tim mạch trong nghiên cứu quan sát; cũng chứa caffeine	C2

Lưu ý văn hoá: cà phê sữa đá Việt Nam đậm caffeine và nhiều đường (sữa đặc). Một ly có thể chiếm phần lớn giới hạn caffeine và đường trong ngày. Cần ước lượng theo cách pha phổ biến (giao bác sĩ dinh dưỡng).

Tăng được nuôi: Khí ● (tỉnh táo, tránh mất nước), Thần ● (qua giấc ngủ, khi dùng đúng giờ).

Trong app: - Check-in: số ly cà phê, trà, nước ngọt; **giờ của ly cà phê cuối**. - Nối trụ Ngủ nghỉ: nếu điểm ngủ thấp và ly cà phê cuối muộn hơn khoảng 6 tiếng trước giờ ngủ, gợi ý **dời ly cuối lên sớm** trước khi gợi ý điều gì khác. Đây là ví dụ của nguyên tắc "gốc của vấn đề có thể nằm ở trụ khác" (lý luận mục IV.3). - Không nói "cà phê có hại". Nói về **liều và giờ**.

Cơ chế 7. Tửu và yên: rượu, thuốc lá

Đông lý. - *Thượng cổ thiên chân luận* chê người đời sau "**dĩ tửu vi tương, dĩ vọng vi thường, tuý dĩ nhập phòng**": lấy rượu làm nước uống, lấy càn bậy làm thường, say rồi vào phòng, nên sống chưa đến nửa đời đã suy. - Rượu tính nhiệt, có độc, sinh **thấp nhiệt**, tổn **Can, Tỳ** [C3 về cơ chế]. - Thuốc lá (yên): nhiệt độc, tổn **Phế** ☹️. - Cả hai thuộc **bất nội ngoại nhân** (lý luận mục VI).

Tây chứng.

Chất	Hiện đại	Cấp
Rượu bia	WHO (2023): không có mức uống an toàn cho sức khỏe. Rượu là chất gây ung thư nhóm 1; gây bệnh gan, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim. Rượu giúp dễ vào giấc nhưng làm vỡ giấc ngủ nửa đêm sau và giảm giấc REM	C1

Chất	Hiện đại	Cấp
Thuốc lá	Nguyên nhân hàng đầu của bệnh phổi, tim mạch, ung thư có thể phòng được. Bỏ thuốc ở bất kỳ tuổi nào đều có lợi	C1
Việt Nam	Tỷ lệ uống rượu bia ở nam giới và tỷ lệ hút thuốc ở nam giới đều cao (lấy số mới nhất từ STEPS, GATS)	C1

Tăng được nuôi (khi giảm hoặc bỏ): Thân ●●●, Khí ●●, Thân ● (giấc ngủ).

Trong app: - Thông điệp trung thực: **"Ít hơn thì tốt hơn"** với rượu. **Không bao giờ** nói "uống rượu vừa phải tốt cho tim" hay quảng bá rượu thuốc, rượu ngâm như dưỡng sinh. - Văn hoá nhậu, cỗ bàn, tiếp khách: gợi ý thực tế 🍷 (xen nước lọc, ăn trước khi uống, đặt giới hạn trước, có ngày không uống trong tuần). Đây là điểm giao với trụ **Môi trường xã hội**. - Thuốc lá: không tự xây chương trình cai thuốc ở phiên bản đầu; **chuyển tiếp** đến dịch vụ tư vấn cai thuốc đã được xác minh tại Việt Nam. - Cờ đỏ: dấu hiệu lệ thuộc rượu (uống buổi sáng, không dùng được, run khi ngưng) → khuyên đi khám. **Cai rượu đột ngột ở người lệ thuộc nặng có thể nguy hiểm**, cần bác sĩ.

Tổng hợp: trụ Ăn uống nuôi bốn tầng

Cơ chế	Thân	Khí	Tâm	Thần	Lời khuyên chủ lực (C1)
0. Tỳ Vị vận hoá (nền)	●●●	●●		●	(khung giải thích)
1. Ngũ cốc vi dưỡng	●●●	●			Rau quả ≥ 400 g; chất xơ ≥ 25 g; bột thịt chế biến
2. Ngũ vị điều hoà	●●●	●			Giảm mặn, giảm đường
3. Tứ khí, thể chất	●	●			(C3, chỉ dùng để tùy chỉnh)
4. Âm thực hữu tiết	●●	●●	●		Không ăn quá nhu cầu
5. Thuận thời	●●			●	Ăn xong 2-3 giờ trước khi ngủ
6. Uống		●		●	Caffeine theo liều và giờ
7. Từ, yên	●●●	●●		●	Ít rượu hơn, không thuốc lá

Bảng này khớp với bảng của lý luận v0.3 (Ăn uống: Thân ●●●, Khí ●). Riêng **Thần ●** (qua giấc ngủ, ở cơ chế 5, 6, 7) là đề xuất bổ sung, cần hội đồng xem xét.

Ăn uống tác động sang các trụ khác

Đường nối	Cơ chế	Cấp
Ăn uống → Ngủ nghỉ	Vị bất hoà tắc ngọạ bất an; ăn khuya, cà phê muộn, rượu làm giấc ngủ kém	C1
Ngủ nghỉ → Ăn uống	Thiếu ngủ làm tăng cảm giác đói, thèm đồ ngọt béo	C1-C2
Cảm xúc → Ăn uống	Hỏa sinh Thổ: tâm an thì ăn ngon; căng thẳng gây ăn theo cảm xúc hoặc chán ăn; tư thương Tỳ	C2

Đường nối	Cơ chế	Cấp
Ăn uống → Cảm xúc	Chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải liên quan nguy cơ trầm cảm thấp hơn; thử nghiệm SMILES (2017) nhỏ nhưng tích cực	C2
Ăn uống → Luyện tập	Đủ năng lượng, đủ đạm thì tập có sức, cơ hồi phục; Tỳ chủ cơ nhục	C1
Thiền → Ăn uống	Ăn chánh niệm	C2
Môi trường → Ăn uống	Bữa cơm gia đình; văn hoá nhậu; môi trường thực phẩm (nhiều quán ăn nhanh, đồ ngọt)	C2

Đo lường trụ Ăn uống 🍴

Theo nguyên tắc đo của lý luận (mục II): nhanh, ít gánh nặng, không gộp điểm, xem xu hướng.

Check-in hàng ngày (dưới 30 giây)

#	Câu hỏi	Trả lời	Cơ chế
1	Hôm nay bạn ăn rau mấy bữa?	0 · 1 · 2 · 3+	1
2	Hôm nay bạn có uống nước ngọt, trà sữa không?	Không · 1 ly · 2+ ly	2, 6
3	Sau bữa chính, bạn thấy thế nào?	Nhẹ · Vừa · Hơi no căng · Rất no	4
4	Bạn ăn xong bữa cuối lúc mấy giờ?	Giờ	5
5	Ly cà phê hoặc trà cuối lúc mấy giờ?	Giờ / Không uống	6
6	Hôm nay bạn có uống rượu bia không?	Không · 1-2 ly · 3+ ly	7

Câu 4-6 có thể bật tắt; người dùng chọn theo trọng tâm tuần (tiệm tiến).

Hàng tuần

- **Tín hiệu Tỳ Vị tự cảm nhận** (0-10): ăn ngon miệng, tiêu hoá nhẹ, đại tiện đều, không đầy bụng.
- **Ăn mặn**: số bữa có chấm, chan nước mắm nhiều; số lần ăn mì gói, đồ chế biến sẵn.

Định kỳ (đề xuất, cần chuyên gia chọn công cụ đã thẩm định tiếng Việt)

- Bảng tần suất thực phẩm rút gọn.
- **AUDIT-C** (3 câu sàng lọc rượu) nếu người dùng có uống rượu.
- Sàng lọc rối loạn ăn uống ngắn (ví dụ SCOFF) trước khi bật bất kỳ tính năng nào liên quan cân nặng.

Không đo

- **Không đếm calo, không chấm điểm món ăn "tốt/xấu"**, không đặt mục tiêu cân nặng ở phiên bản đầu.

- Không chụp ảnh món ăn để AI chấm điểm (độ chính xác thấp, dễ gây lo âu).

An toàn riêng cho trụ Ăn uống

Bổ sung vào mục X của lý luận. **Cần bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng duyệt.**

Cờ đỏ cần đi khám

Dấu hiệu	Hành động
Sụt cân không chủ ý (ví dụ trên 5% trong 6 tháng)	Khuyến đi khám
Khó nuốt, nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc có máu, đau bụng kéo dài	Khuyến đi khám ngay
Thay đổi thói quen đại tiện kéo dài, nhất là sau 45-50 tuổi	Khuyến đi khám (tầm soát đại trực tràng)
Dấu hiệu rối loạn ăn uống: sợ tăng cân, nhịn ăn kéo dài, ăn vô độ rồi nôn, sàng lọc dương tính	Dừng mọi lời khuyên về lượng ăn; khuyến gặp chuyên gia
Dấu hiệu lệ thuộc rượu	Khuyến đi khám; cảnh báo không tự cai đột ngột nếu uống nặng

Chế độ ăn cực đoan

Lục Dưỡng **không khuyến nghị** và sẽ **cảnh báo** khi người dùng theo: - Chế độ chỉ ăn một loại (ví dụ chỉ gạo lứt muối mè kéo dài). Đã có những ca suy dinh dưỡng, tổn thương nặng khi áp dụng cực đoan. - Nhịn ăn nhiều ngày, "thải độc" bằng nước ép hay thực phẩm chức năng. - **Bỏ thuốc điều trị** để chữa bệnh bằng ăn uống.

Câu chuẩn trong app: *"Ăn uống là nền của sức khỏe, nhưng không thay thế điều trị. Hãy giữ thuốc bác sĩ kê và trao đổi với bác sĩ trước khi thay đổi lớn chế độ ăn."*

Khoá theo tình trạng (bổ sung)

Tình trạng	Khoá
Đái tháo đường đang dùng thuốc hạ đường huyết, insulin	Khoá gợi ý bỏ bữa, ăn khung giờ giới hạn (nguy cơ hạ đường huyết)
Bệnh thận mạn	Khoá gợi ý tăng đạm, tăng rau quả nhiều kali; kèm "hỏi bác sĩ"
Dùng thuốc chống đông warfarin	Nhắc giữ lượng rau lá xanh ổn định (vitamin K); hỏi bác sĩ
Bệnh gout	Lời khuyên đạm, rượu bia kèm "hỏi bác sĩ"
Dị ứng, không dung nạp thức ăn	Lọc mọi gợi ý món ăn
Thai kỳ, cho con bú	Giới hạn caffeine thấp hơn; khoá dược liệu, nhịn ăn; nhắc tránh rượu hoàn toàn

Lộ trình tiệm tiến gợi ý 🍴

Mỗi tuần chọn **1-2 việc**, theo tăng đang yếu và lời khuyên C1 trước:

Tuần	Trọng tâm	Việc nhỏ
1	Thuận thời	Ăn xong bữa tối trước giờ ngủ 3 tiếng
2	Ngũ vị	Pha loãng nước mắm chấm; không chan nước mắm vào cơm
3	Ngũ cốc vi dưỡng	Thêm rau vào bữa sáng hoặc bữa trưa
4	Uống	Đổi một ly nước ngọt hoặc trà sữa thành trà, nước lọc; dời ly cà phê cuối trước 14h
5	Hữu tiết	"Ba miếng đầu chánh niệm"; dừng ở bảy, tám phần no
6	Tứ khí	Thêm một món theo mùa, có lọc thể chất

Người uống rượu, hút thuốc: ưu tiên cơ chế 7 sớm, vì tác động lớn nhất.

Việc cần hội đồng thẩm định

Lương y: 1. Đối chiếu nguyên văn: *Linh lan bí điển luận, Kinh mạch biệt luận, Tạng khí pháp thời luận, Tuyên minh ngũ khí, Sinh khí thông thiên luận, Ngũ tạng sinh thành, Kỳ bệnh luận, Chí chân yếu đại luận, Tý luận, Nghịch điều luận, Thượng cổ thiên chân luận*; xuất xứ câu "hữu Vị khí tắc sinh". 2. Bảng tính vị (hàn nhiệt) của thực phẩm Việt thông dụng; phép phối hàn nhiệt trong bữa cơm Việt. 3. Nguyên văn về ăn uống trong "Vệ sinh yếu quyết" (Hải Thượng Lãn Ông) và trước tác của Tuệ Tĩnh. 4. Gợi ý theo mùa cho miền Bắc, miền Nam, vùng cao.

Bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng: 5. Tỷ lệ "đĩa cơm Việt"; đối chiếu Tháp dinh dưỡng và Lời khuyên dinh dưỡng hợp lý của Viện Dinh dưỡng Quốc gia. 6. Số liệu mới nhất về muối, đường, rượu bia, thuốc lá ở người Việt. 7. Lượng caffeine, đường trong các thức uống phổ biến (cà phê sữa đá, trà sữa). 8. Bộ câu hỏi check-in và công cụ sàng lọc (AUDIT-C, SCOFF) có bản tiếng Việt đã thẩm định. 9. Danh sách cờ đỏ và khoá theo bệnh. 10. Xếp cấp C1/C2/C3 cho từng khẳng định trong tài liệu này.

Chuyên gia tâm lý: 11. Rủi ro rối loạn ăn uống khi theo dõi ăn uống; cách nói không gây mặc cảm.